GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 4/2025

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2025.

ASSUNTO: Apresenta esclarecimentos quanto à pertinência de se enquadrar a política de Acesso Eletivo executada pela Secretaria de Estado de Saúde no rol financiado com recursos do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente nota técnica tem como objetivo esclarecer o enquadramento da política de Acesso Eletivo, executada pela Secretaria de Estado de Saúde, como elegível para ser financiada com os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM. Adicionalmente, busca-se assegurar que as despesas realizadas com estes recursos sejam consideradas no computo do índice constitucional de ações e serviços públicos de saúde, apurado para o exercício de 2024.

2. DA LEGIMITIDADE DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE COM RECURSOS DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

O Fundo de Erradicação da Miséria – FEM, no âmbito de Minas Gerais, foi criado pela Lei nº 19.990/2011 e tem como objetivo custear os programas e ações de erradicação da pobreza e da extrema pobreza.

Sua principal fonte de financiamento decorre das receitas do adicional de até 2% na alíquota do ICMS, que incide sobre um rol de produtos e serviços supérfluos. Recentemente, a cobrança deste adicional foi renovada por meio da edição da Lei nº 24.471/2023, que permite a cobrança até 2026.

De acordo com o inciso VII do art. 10. da Lei nº 19.990/2011, a Secretaria de Estado de Saúde está elencada com um dos órgãos autorizados a executarem recursos do FEM.

> Art. 10. São agentes executores do FEM:
>
> (...)
>
> VII – a Secretaria de Estado de Saúde;

Ademais, a mesma Secretaria, de acordo com o Art. 8º, tem cadeira no Grupo Coordenador do fundo, que é a instância deliberativa responsável, dentre outras atribuições, pela aprovação do plano de trabalho de aplicação dos recursos do fundo e pela elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria.

> Art. 8° Integram o grupo coordenador do FEM um representante:
>
> (...)
>
> VIII – da Secretaria de Estado de Saúde;
>
> (...)

> § 4º – Cabem ao grupo coordenador do FEM, no exercício das competências previstas no inciso IV do caput do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006:
>
> I – a elaboração de Plano Mineiro de Combate à Miséria;
>
> II – a aprovação anual de plano de trabalho, contendo a discriminação das dotações orçamentárias do FEM, sendo demonstrada a aplicação no plano das receitas resultantes da aplicação do disposto no § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, na forma da legislação estadual específica.

Neste contexto, é possível perceber que o legislador, ao regulamentar o Fundo de Erradicação da Miséria, entendeu relevante incluir a pasta responsável pelas políticas de saúde do Estado, como competente tanto para executar os recursos do FEM, quanto para definir a alocação dos recursos nas políticas públicas do Estado.

Dito isso, passemos na seção a seguir para a análise da política elegida para ser contemplada com os recursos do fundo, no exercício de 2024.

3. DO ENQUADRAMENTO DA POLÍTICA DO ACESSO ELETIVO NO ROL DE PROGRAMAS E AÇÕES QUE PODEM SER FINANCIADOS COM RECURSOS DO FEM

Em 2024, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) optou por alocar os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria (FEM) na ação 4135 – Acesso Eletivo, executada pelo Fundo Estadual de Saúde (FES). A referida ação tem como finalidade "viabilizar o acesso dos usuários do SUS/MG aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos, por meio de políticas de transporte em saúde e regulação de eletivos".

Visando atender o caráter de acesso universal da saúde, a ação, assim como outras realizadas pela SES, tem como público alvo os "usuários do SUS/MG". Cientes de que dentro deste universo, pela própria natureza da política, existe uma demanda significativa de usuários que coincidem com o público alvo do Fundo, entendeu-se oportuno que parte dos recursos alocados na ação fosse oriundo do Fundo de Erradicação da Miséria.

Em números, temos que dos R$418,9 milhões empenhados, R$100 milhões foram de recursos do FEM, o que representa em torno de 23,87% do total. Dentro deste montante, destaca-se o repasse de valores para municípios que apresentam Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS - abaixo de 0,513, conforme dados publicados em 2020 pela Fundação João Pinheiro, sendo estes: (a) Aguas Formosas – R$1.080.00,00 (IMRS 0,47); (b) Conceição do Mato Dentro – R$ 1.833.000,00 (IMRS 0,496); (c) Januária – R$ 3.055.000,00 (IMRS 0,508) e (d) Jacinto – R$ 4.888.000,00 (IMRS 0,513).

Importante mencionar que, mesmo em municípios com IMRS mais elevado, há bairros e regiões com a presença de uma população mais vulnerável e em situação de pobreza. Vale ressaltar também, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que as taxas de pobreza e de extrema pobreza em Minas Gerais em 2023 foram de 20,2% e 2,2%, respectivamente.

Em suma, entende-se que no caso da ação Acesso Eletivo o público-alvo se enquadra nas determinações legais exigidas para aplicação de recursos do FEM, caracterizando-se como, majoritariamente, indivíduos de baixas condições socioeconômicas e, em grande parte, provenientes de municípios com baixa estrutura de atendimento à saúde e, portanto, em situação de vulnerabilidade.

Esclarecida a questão do público-alvo da ação, seguimos para o enquadramento da política no art. 4º da Lei nº 19.990/2011:

> Art. 4° Os recursos do FEM serão aplicados **prioritariamente** em programas e ações que tenham as seguintes finalidades:
>
> **I – enfrentar as situações de pobreza e desigualdade;**
>
> II – promover a proteção social por meio de serviços e benefícios socioassistenciais no âmbito da política de assistência social;
>
> III – reforçar a renda das famílias;

IV – assegurar o direito à alimentação adequada;

V – **melhorar o padrão de vida** e as condições de habitação, saneamento básico e acesso à água;

VI – gerar novas oportunidades de trabalho e emprego;

VII – promover a formação profissional.

VIII – mitigar, nos prazos e nas condições definidos em regulamento, os efeitos dos danos socioeconômicos decorrentes da decretação de estado de calamidade pública para os beneficiários previstos no art. 6º.

(grifo nosso)

A lei de criação do fundo elenca a finalidade dos programas e ações que, prioritariamente, devem receber recursos para erradicação da miséria. Dentre os dispositivos citados, podemos dizer que a política de Acesso Eletivo da Secretaria de Saúde melhor se enquadra no disposto nos incisos I – enfrentar as situações de pobreza e desigualdade – e V – melhorar o padrão de vida e as condições de habitação, saneamento básico e acesso à água, neste último no tocante à melhoria do padrão de vida.

O combate à pobreza e à desigualdade social exige políticas e ações que garantam o acesso a direitos básicos, promovam inclusão social e ofereçam oportunidades de crescimento para as populações mais vulneráveis. Essas ações devem abranger áreas como saúde, educação, geração de emprego e assistência social. Olhando sob um viés mais amplo, a melhoria da saúde tem um impacto direto na qualidade de vida da população vulnerável, ajudando a romper o ciclo da pobreza e garantindo mais oportunidades de desenvolvimento social e econômico.

No caso especifico da ação 4135 – Acesso Eletivo, o que se visa é a garantia de um serviço essencial de acesso da população à consultas, exames e tratamentos médicos. Em municípios pobres e vulneráveis, esse transporte desempenha um papel ainda mais crucial, pois muitos pacientes enfrentam dificuldades financeiras e estruturais para chegar às unidades de saúde, o que perpetua a situação de vulnerabilidade social em que se encontram.

Neste sentido, o fortalecimento das consultas eletivas, aliado a programas de transporte e conscientização, garante que essas populações tenham atendimento adequado, o que é especialmente importante no caso de pacientes com doenças crônicas e no diagnóstico precoce de diversas doenças, podendo evitar internações e tratamentos mais dispendiosos.

Este caráter preventivo e de acompanhamento regular das consultas eletivas é de extrema relevância para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, refletindo em uma série de fatores que ajudam diretamente no enfrentamento das desigualdades sociais, tais como:

a) Maior Capacidade para o Trabalho e Geração de Renda: pessoas saudáveis têm mais condições de trabalhar e de se manter produtivas. A redução de doenças crônicas e incapacidades melhora a empregabilidade e a estabilidade financeira das famílias, auxiliando-as a sair da trajetória de pobreza;

b) Redução de Gastos com Saúde e Endividamento Familiar: o acesso a consultas e tratamentos preventivos evita doenças graves que exigem internações caras e prolongadas. Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza frequentemente se endividam para pagar tratamentos médicos quando o sistema público falha, agravando sua situação financeira;

c) Redução da Mortalidade e Aumento da Expectativa de Vida: acesso a serviços de saúde reduz índices de mortalidade infantil, materna e de doenças evitáveis. Populações com maior expectativa de vida têm mais oportunidades de melhorar sua condição social ao longo do tempo;

d) Menos Desigualdade no Acesso a Oportunidades: enfermos ou com deficiência sem tratamento adequado enfrentam mais dificuldades para estudar, trabalhar e acessar serviços básicos;

e) Redução do Ciclo da Pobreza Intergeracional: a melhoria na saúde familiar permite que novas gerações tenham mais oportunidades e mobilidade social.

Diante do exposto, entende-se que o escopo de atuação da política elegida pela SES se enquadra no que preconiza a lei do FEM ao permitir diretamente a melhoria de qualidade de vida da população usuária do

SUS em situação de vulnerabilidade social e indiretamente promover, por uma série de fatores demonstrados, sua saída da trajetória de pobreza, não havendo desvio de objeto ou público-alvo.

Finalmente, aproveitando o ensejo de discussão da alocação de recursos do FEM nas políticas de saúde, entende-se oportuno reforçar o entendimento desta unidade que os valores executados com a fonte 71 também devem ser incluídos no computo do índice constitucional de Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, o que será detalhado na próxima seção.

4. DO CÔMPUTO DA DESPESA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

O art. 6 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, dispõe sobre o percentual e a base de cálculo relativos à destinação de recursos para Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, estabelecidos no art. 198 da Constituição Federal de 1988.

Art. 6o Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

Como a receita decorrente do adicional de até 2% na alíquota do ICMS que incide sobre um rol de produtos e serviços supérfluos e que é direcionada ao Fundo de Erradicação da Miséria compõe esta base de cálculo, entende-se passível de cômputo em ASPS as despesas que forem realizadas com esta receita, desde que não contrariem a LC 141/2012, conforme especificado na seção 2 desta nota técnica.

Ademais, destaca-se que há ações destinadas à saúde que se enquadram simultaneamente em critérios de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e em critérios de aplicação de recursos do FEM. Para tanto, as ações com recursos do FEM que podem ser aplicadas no cálculo do mínimo em ASPS devem observar as seguintes determinações legais:

> I) Ser de responsabilidade específica do setor da saúde (vide art. 2º da LC 141/12) e atuar sobre a saúde e o SUS (conforme disposições do art. 3º - LC 141/12);
>
> II) Não constituir ação no âmbito de políticas de assistência social (vide art. 4º, inciso VIII da LC 141/12);
>
> III) Ter como objetivo a erradicação da pobreza e da extrema pobreza (vide art. 1º da Lei 19.990/11), promovendo a proteção social, a renda, a alimentação, o emprego e melhores condições de vida, conforme especificado no art. 4º da Lei 19.990/11;
>
> IV) Ter como beneficiários os indivíduos em situações de pobreza e extrema pobreza e as famílias em situação de baixa renda ou privação social (vide art. 6º da Lei 19.990/11).

Considerando que a política Acesso Eletivo, objeto de análise em questão, enquadra-se no disposto nos artigos 2º e 3º da Lei Complementar, conforme destacado acima, não esbarrando em vedação do art. 4º, e no disposto na Lei 19.990/11 que institui o FEM, conforme discutido no tópico anterior, esta unidade entende como legítimo computar no índice constitucional de saúde, para além das despesas executadas com recursos ordinários, aquelas realizadas com os recursos do FEM.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Nota Técnica objetivou apresentar subsídios para que a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG acate o enquadramento das despesas realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde – SES no rol das elegíveis para serem financiadas com recursos do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM.

Para isso, inicialmente explicitou-se que a Secretaria de Estado de Saúde, tem autorização legal para executar recursos do Fundo e que participa como membro da instância deliberativa de alocação dos recursos que custeiam programas e ações que contribuem para a erradicação da pobreza.

Posteriormente, foi analisada a execução dos recursos e os atributos qualitativos da ação "Acesso Eletivo", de modo a justificar o quanto esta política pode contribuir para o objetivo do FEM, contemplando seu público-alvo e suas finalidades principais.

Entendeu-se, ainda, relevante abordar a questão do cômputo das despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, dado que a receita do fundo compõe a base de cálculo do índice constitucional e que a despesa executada pela ação se enquadra no disposto na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012.

Finalmente, considerando que a análise desta Subsecretaria se restringiu as informações qualitativas contidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e nas variáveis orçamentárias de execução de despesa da política de Acesso Eletivo, recomenda-se que a demanda seja apreciada pela Secretaria de Estado de Saúde, responsável pela política pública para que possa agregar a discussão com informações técnicas, sobretudo quanto ao público-alvo da ação em questão.

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Subsecretário de Planejamento e Orçamento - SPLOR

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 17/02/2025, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **107676902** e o código CRC **F002C712**.

Referência: Processo nº 1500.01.0068907/2025-05 SEI nº 107676902